

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

Kit Victime d'erreur médicale

Constituez votre dossier médical.

CONÇU ET RÉDIGÉ PAR

Maître Patrice Humbert

Avocat spécialiste CNB en dommage corporel · Barreau d'Aix-en-Provence

LEXVOX

ÉDITION 2026 · LEXVOX-VICTIME.COM

Dans ce guide

Kit Victime d'erreur médicale : 6 documents.

1. Obtenir votre dossier médical
2. La chronologie des soins
3. Le journal des symptômes et séquelles
4. La carte des 3 voies
5. Les 10 signaux d'une possible erreur médicale
6. Le lexique et les textes de référence (erreur médicale)

Obtenir votre dossier médical

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre votre droit d'accès à l'intégralité de votre dossier médical, ses délais et sa gratuité de consultation, appuyés sur le texte exact du code de la santé publique. - Écrire, sans hésiter, un courrier de demande complet et réclamer la liste exhaustive des pièces qui composent votre dossier. - Réagir efficacement en cas de silence, en connaissant la voie de recours exacte selon que vous vous adressez à un hôpital public ou à un praticien libéral.

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Pourquoi le dossier médical est votre première pièce

Après une hospitalisation qui s'est mal passée, une opération aux suites inattendues, une prise en charge qui vous laisse un doute, une question revient toujours : que s'est-il réellement passé ? La réponse est écrite. Elle se trouve dans votre dossier médical.

Ce dossier est le récit heure par heure de vos soins. Il contient les décisions prises, les gestes effectués, les médicaments administrés, les résultats d'examens, les surveillances relevées. C'est la mémoire objective de votre parcours. Sans lui, aucune analyse sérieuse n'est possible, ni par vous, ni par un médecin conseil, ni par un avocat.

Obtenir ce dossier n'est pas un affrontement. C'est un droit reconnu à toute personne, exercé chaque jour, dont l'établissement connaît parfaitement les modalités. Vous n'avez pas à justifier votre demande. Vous n'avez pas à

annoncer une éventuelle contestation. Vous demandez simplement les informations qui vous concernent, parce qu'elles sont les vôtres.

Ce document vous guide pas à pas. Il vous donne le fondement légal, un modèle de courrier prêt à l'emploi, la liste complète des pièces à réclamer, la réalité des frais, et la marche à suivre si l'on ne vous répond pas.

Votre droit d'accès : ce que dit la loi

Le droit d'accès au dossier médical est posé par l'article L1111-7 du code de la santé publique. Ce texte reconnaît à toute personne l'accès à l'ensemble des informations de santé la concernant. Voici sa formulation exacte sur les modalités et les délais :

« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans. »

Article L1111-7 du code de la santé publique, consultable sur

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685313

Trois enseignements pratiques se dégagent de ce texte.

Le délai de principe est de 8 jours. À compter de la réception de votre demande, l'établissement ou le praticien dispose d'un délai maximum de 8 jours pour vous communiquer le dossier. Ce délai est un plafond, non une durée normale : rien n'interdit une communication plus rapide.

Un délai de réflexion de 48 heures existe. La communication intervient au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures. Ce court délai protège le patient : il ménage un temps entre la demande et la remise de documents parfois lourds à recevoir. Il ne rallonge pas réellement l'attente, puisqu'il s'inscrit dans les 8 jours.

Le délai passe à 2 mois pour les dossiers anciens. Lorsque les informations demandées datent de plus de 5 ans, le délai de communication est porté à 2 mois. Ce point 5 ans se compte à partir de la date à laquelle l'information a été constituée, et non à partir de la fin de votre séjour.

Retenez ces repères simples : 8 jours pour un dossier récent, 2 mois pour un dossier de plus de 5 ans, avec un délai de réflexion de 48 heures qui court dans l'intervalle.

La consultation sur place est gratuite

Le même droit vous ouvre deux voies distinctes. Vous pouvez demander une copie des pièces, qui vous est envoyée ou remise, ou consulter votre dossier sur place, dans les locaux de l'établissement. La consultation sur place est gratuite. Seule la reproduction des documents, si vous en demandez une copie, peut donner lieu à des frais, traités plus loin dans ce document.

La consultation sur place présente un intérêt réel quand le dossier est volumineux. Elle vous permet de le parcourir, d'identifier les pièces utiles, puis de ne demander en copie que celles qui comptent. Vous pouvez vous y faire

accompagner par un médecin de votre choix.

Un accès direct, sans intermédiaire obligatoire

Vous pouvez accéder à votre dossier directement, sans passer par un médecin. La loi prévoit la possibilité de désigner un médecin intermédiaire, mais il s'agit d'une faculté offerte au patient, jamais d'une condition imposée. Un établissement ne peut pas exiger que vous passiez par un praticien pour recevoir vos propres informations.

Le cas particulier du décès d'un proche

Si vous êtes l'ayant droit d'une personne décédée, votre accès obéit à des règles voisines mais spécifiques. L'article L1110-4 du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à la communication d'informations aux ayants droit, dès lors qu'elles leur sont nécessaires pour l'un des trois motifs suivants :

« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

Article L1110-4 du code de la santé publique, consultable sur
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043895798

Dans ce cas, précisez dans votre courrier votre qualité d'ayant droit et le motif que vous invoquez parmi ces trois. Joignez un justificatif de votre lien avec le défunt, par exemple un acte de notoriété ou un livret de famille.

À qui adresser votre demande

L'interlocuteur dépend du lieu où vous avez été soigné. Identifier le bon destinataire évite les renvois et fait gagner du temps.

L'établissement de santé, public ou privé

Si vous avez été hospitalisé, la demande s'adresse à l'établissement, et non au médecin qui vous a suivi personnellement. C'est l'établissement qui détient et conserve le dossier.

En pratique, écrivez au directeur de l'établissement, ou au service en charge des relations avec les usagers, souvent appelé service des usagers ou bureau des admissions et des dossiers médicaux. Cette règle vaut aussi bien pour un hôpital public que pour une clinique privée. La forme change peu ; seule la voie de recours en cas de silence diffère, comme expliqué plus loin.

Le praticien libéral

Si vous avez été suivi par un médecin exerçant en cabinet, par exemple un chirurgien, un spécialiste ou votre médecin traitant, la demande s'adresse directement à ce praticien. C'est lui qui détient le dossier constitué à l'occasion de vos consultations.

Adressez-lui votre courrier à l'adresse de son cabinet. Un praticien libéral est tenu aux mêmes obligations de communication que l'établissement, dans les mêmes délais.

Le cas fréquent des soins mixtes

Beaucoup de parcours mêlent les deux. Vous avez été opéré en clinique par un chirurgien libéral, suivi ensuite en consultation, avec des examens réalisés dans un laboratoire. Dans ce cas, adressez une demande à chaque détenteur : la clinique pour le dossier d'hospitalisation, le chirurgien pour ses consultations, le laboratoire ou le centre d'imagerie pour les examens. Réunir toutes les pièces suppose parfois plusieurs courriers.

Le modèle de courrier de demande

Voici un modèle complet. Remplacez chaque zone entre crochets [] par votre information, puis relisez avant de signer. Ne laissez jamais un crochet dans le courrier final. Envoyez toujours ce courrier en recommandé avec accusé de réception, et conservez la preuve de dépôt : elle fait courir les délais et prouve votre demande.

[Vos nom, prénom, et nom de naissance] [Votre date de naissance] [Votre adresse complète] [Code postal, ville]
[Téléphone, adresse électronique]

[Nom de l'établissement / du praticien] [À l'attention du directeur ou du service des relations avec les usagers, le cas échéant] [Adresse complète] [Code postal, ville]

À [ville], le [date]

Objet : demande de communication de mon dossier médical (article L1111-7 du code de la santé publique) Envoi recommandé avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

J'ai été pris(e) en charge au sein de votre [établissement / cabinet] à l'occasion de [séjour, hospitalisation, intervention ou consultation], du [date de début] au [date de fin], sous le numéro de dossier ou d'admission [numéro si vous le connaissez].

En application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, je sollicite la communication de l'intégralité des informations de santé me concernant et figurant à mon dossier.

Je vous demande de me délivrer une copie des pièces suivantes, ainsi que de toute autre pièce composant mon dossier : - le compte rendu d'hospitalisation et le compte rendu de sortie ; - les comptes rendus opératoires et les comptes rendus d'anesthésie ; - le dossier de soins infirmiers ; - les feuilles et courbes de surveillance (constantes, feuilles de température, feuilles de réanimation ou de salle de réveil) ; - l'ensemble des prescriptions médicales et des feuilles d'administration des médicaments ; - les résultats de tous les examens réalisés (analyses biologiques, imagerie, avec les images et les comptes rendus radiologiques) ; - les comptes rendus de consultation ; - les courriers échangés entre praticiens et avec mon médecin traitant ; - le formulaire de consentement éclairé signé, le cas échéant ; - la fiche d'anesthésie et la consultation pré-anesthésique ; - les transmissions et observations infirmières.

Je souhaite recevoir cette copie [par voie postale à l'adresse ci-dessus / par un accès sécurisé]. Je vous remercie de m'indiquer, le cas échéant, le montant des frais de reproduction et d'envoi, que je réglerai.

Je vous rappelle que ces informations doivent m'être communiquées au plus tard dans les huit jours suivant la présente demande, ce délai étant porté à deux mois si elles datent de plus de cinq ans.

Je joins la copie d'une pièce d'identité afin de justifier de ma qualité.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

[Signature] [Nom et prénom]

Bon à savoir. Joignez toujours une copie de votre pièce d'identité. L'établissement doit s'assurer que les informations de santé sont remises à la bonne personne : cette vérification protège votre secret médical. Sans justificatif d'identité, la demande peut être légitimement suspendue.

Si vous demandez le dossier d'un proche décédé, adaptez l'objet et le corps du courrier : indiquez votre qualité d'ayant droit, le motif invoqué parmi les trois prévus par l'article L1110-4, et joignez un justificatif de votre lien de parenté.

Les pièces à réclamer, sans rien oublier

Un dossier médical ne se résume pas au compte rendu de sortie. Ce compte rendu est une synthèse ; il masque le détail des soins. Or c'est souvent dans le détail que se lit ce qui s'est réellement passé. Demandez donc l'intégralité, et vérifiez ensuite la présence de chaque pièce.

Les catégories qui suivent recouvrent la quasi-totalité d'un dossier d'hospitalisation.

Les comptes rendus médicaux. Compte rendu d'hospitalisation, compte rendu de sortie, compte rendu opératoire pour chaque intervention, compte rendu d'anesthésie, comptes rendus de consultation. Ces documents décrivent les décisions et les gestes.

Le dossier de soins infirmiers. Il contient les transmissions, les observations, les diagrammes de soins. C'est le relevé quotidien de votre prise en charge par l'équipe soignante. Il est souvent le plus révélateur du déroulement réel, heure par heure.

Les feuilles de surveillance. Feuilles de température, courbes de constantes, feuilles de réanimation, feuilles de salle de réveil. Elles enregistrent l'évolution de votre état et les alertes éventuelles.

Les prescriptions et l'administration des médicaments. Les ordonnances internes, les prescriptions, et surtout les feuilles d'administration qui indiquent quel médicament a été donné, à quelle dose, à quelle heure, par qui.

Les résultats d'examens. Analyses de biologie, comptes rendus d'imagerie, et les images elles-mêmes (radiographies, scanners, IRM). Demandez à la fois le compte rendu écrit et le support de l'image.

La correspondance. Les courriers entre praticiens, les lettres adressées à votre médecin traitant, les demandes d'avis à un confrère. Ces échanges éclairent le raisonnement médical et la circulation de l'information.

Les documents relatifs à l'anesthésie. Consultation pré-anesthésique, fiche d'anesthésie, surveillance péri-opératoire.

Les documents de consentement. Le formulaire de consentement éclairé que vous auriez signé, et toute fiche d'information qui vous aurait été remise.

Ne présumez jamais qu'une pièce serait sans intérêt. Une simple courbe de surveillance ou une transmission infirmière peut se révéler décisive. Demandez tout, triez ensuite.

Les frais de copie

La consultation sur place est gratuite. En revanche, si vous demandez une copie de votre dossier, les frais de reproduction et, le cas échéant, d'envoi peuvent être mis à votre charge. C'est le seul coût prévu.

Ces frais sont encadrés. Ils ne peuvent excéder le coût de la reproduction des documents et, si vous demandez un envoi, le coût de l'expédition. Autrement dit, un établissement ne peut pas facturer un forfait de dossier, ni un temps de recherche, ni une prestation : il facture le papier copié, le support numérique gravé, et le port. Le montant réclamé doit rester en rapport avec ce coût réel.

En pratique, pour limiter les frais d'un dossier volumineux, deux réflexes aident. Premièrement, demandez d'abord à consulter le dossier sur place, gratuitement, puis ne réclamez en copie que les pièces utiles. Deuxièmement, acceptez une remise sur support numérique quand elle est proposée : elle coûte souvent moins cher que la photocopie.

Demandez toujours, dans votre courrier, à connaître le montant des frais avant l'envoi. Vous évitez ainsi la surprise et vous gardez une trace du coût annoncé.

Que faire en cas de silence

Le délai est passé et vous n'avez rien reçu. Cette situation est fréquente et se résout dans la plupart des cas par une relance. Procédez par étapes, du plus simple au plus formel.

Étape 1 : la relance écrite

Adressez une relance en recommandé avec accusé de réception. Rappelez la date de votre première demande, joignez-en une copie, et rappelez le délai légal dépassé. Une relance ferme et datée suffit souvent à débloquent un dossier oublié.

Objet : relance, demande de communication de mon dossier médical restée sans réponse

Madame, Monsieur, Par courrier recommandé du [date], dont je joins copie, je vous ai demandé la communication de mon dossier médical en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. À ce jour, le délai légal est écoulé et je n'ai reçu aucune réponse. Je réitère ma demande et vous remercie d'y donner suite sous quinzaine.

Étape 2 : la voie de recours, différente selon le détenteur

Si la relance reste sans effet, la voie de recours dépend de la nature du détenteur. Ce point est essentiel : un hôpital public et un praticien libéral ne relèvent pas de la même autorité.

Pour un établissement PUBLIC : la saisine de la CADA. Le dossier détenu par un hôpital public est un document administratif. Son refus de communication relève de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Le fondement se trouve à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration :

« les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »

Article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033218946

Concrètement, saisissez la CADA d'une demande d'avis, en joignant la copie de votre demande initiale et de sa relance restée sans réponse. La CADA rend un avis sur le caractère communicable du dossier. Cette étape est un préalable utile avant tout recours contentieux devant le juge administratif.

Pour un praticien LIBÉRAL : la saisine du conseil de l'Ordre. Le praticien libéral ne relève pas de la CADA, puisqu'il ne s'agit pas d'une administration. Son obligation de communication découle de son devoir déontologique. En cas de refus, la voie est la saisine du conseil départemental de l'Ordre des médecins, garant du respect du code de

déontologie médicale. Ce code prévoit, à l'article R4127-46 du code de la santé publique, les conditions d'accès au dossier par l'intermédiaire d'un médecin :

« Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts. »

Article R4127-46 du code de la santé publique, consultable sur
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025843577

Adressez au conseil départemental de l'Ordre des médecins du lieu d'exercice du praticien un courrier exposant votre demande, sa date, la relance, et l'absence de réponse. Le conseil de l'Ordre peut rappeler le praticien à ses obligations déontologiques et intervenir en conciliation.

Ce que ce document n'invente pas. Aucun article n'est cité ici en dehors de son fondement réel. La saisine de l'Ordre est présentée comme une voie déontologique, rattachée au devoir de communication du praticien, sans référence à un pouvoir disciplinaire chiffré ou daté qui ne serait pas vérifié.

Étape 3 : l'appui d'un avocat

Si le blocage persiste malgré ces démarches, l'intervention d'un avocat spécialisé accélère souvent la remise du dossier. Une demande formulée par un conseil, sur le bon fondement et devant la bonne autorité, est rarement ignorée.

Vérifier la complétude de votre dossier

Recevoir un dossier ne suffit pas : encore faut-il qu'il soit complet. Un dossier amputé d'une pièce clé peut fausser toute la lecture des faits. Passez chaque envoi au crible de cette liste. Cochez chaque pièce reçue, et identifiez les manques pour les réclamer par une demande complémentaire.

Checklist des 15 pièces à vérifier

- ☐ 1. Compte rendu d'hospitalisation
- ☐ 2. Compte rendu de sortie
- ☐ 3. Comptes rendus opératoires (un par intervention)
- ☐ 4. Comptes rendus et fiches d'anesthésie
- ☐ 5. Consultation pré-anesthésique
- ☐ 6. Dossier de soins infirmiers (transmissions et observations)
- ☐ 7. Diagrammes de soins et feuilles de surveillance
- ☐ 8. Feuilles de température et courbes de constantes
- ☐ 9. Feuille de salle de réveil ou de réanimation
- ☐ 10. Prescriptions médicales
- ☐ 11. Feuilles d'administration des médicaments

- [] 12. Résultats d'analyses biologiques
- [] 13. Comptes rendus d'imagerie et images (radiographies, scanners, IRM)
- [] 14. Courriers entre praticiens et avec le médecin traitant
- [] 15. Formulaire de consentement éclairé signé

Un contrôle simple complète cette liste : vérifiez la continuité des dates. Un jour de séjour sans aucune trace de soins, une surveillance qui s'interrompt, une prescription sans feuille d'administration correspondante sont autant de signaux d'une pièce manquante. Notez chaque anomalie et demandez la pièce absente par un courrier complémentaire, sur le même fondement.

Questions fréquentes

Dois-je expliquer pourquoi je demande mon dossier ? Non. Le droit d'accès n'est soumis à aucune justification de motif. Vous n'avez pas à annoncer une contestation ni à exposer vos intentions. Une demande sobre, fondée sur l'article L1111-7, suffit.

Peut-on me refuser l'accès à certaines pièces ? L'accès porte sur l'ensemble des informations de santé vous concernant. Certaines mentions relatives à des tiers ou recueillies auprès de tiers n'ont pas à vous être communiquées, mais elles constituent l'exception et non la règle. Le corps du dossier, celui qui décrit vos soins, vous est communicable.

Combien de temps mon dossier est-il conservé ? Les durées de conservation varient selon les situations. Ne tardez pas pour autant : plus la demande est précoce, plus le dossier est complet et facile à retrouver. Un dossier ancien relève du délai de communication de 2 mois, non de 8 jours.

Puis-je demander mon dossier par voie électronique ? Oui, si l'établissement propose un accès sécurisé. Précisez-le dans votre courrier. La copie sur support numérique est souvent moins coûteuse que la photocopie papier.

Le médecin peut-il exiger que je vienne accompagné d'un médecin ? Non. La désignation d'un médecin intermédiaire est une faculté offerte au patient, jamais une condition. Vous pouvez accéder directement à vos informations.

J'ai perdu mon numéro de dossier, est-ce bloquant ? Non. Indiquez vos nom, nom de naissance, date de naissance, ainsi que les dates et le service de votre prise en charge. Ces éléments suffisent à retrouver votre dossier.

Que faire si le dossier reçu paraît incomplet ? Comparez-le à la checklist des 15 pièces plus haut, repérez les manques, puis adressez une demande complémentaire ciblée sur les pièces absentes, sur le même fondement légal.

Lexique des termes utilisés

Ayant droit : personne qui, du fait de son lien avec un défunt (héritier, concubin, partenaire de PACS), peut faire valoir certains droits, dont l'accès à des informations médicales dans les conditions de la loi.

CADA : Commission d'accès aux documents administratifs. Autorité qui rend un avis sur le caractère communicable d'un document détenu par une administration, dont un hôpital public.

Consentement éclairé : accord donné par le patient à un acte de soins après avoir reçu une information sur cet acte, ses risques et ses alternatives.

Document administratif : document produit ou détenu par une administration dans le cadre de sa mission de service public. Le dossier médical d'un hôpital public en fait partie.

Dossier de soins infirmiers : ensemble des transmissions, observations et diagrammes tenus par l'équipe soignante, qui retrace au jour le jour la prise en charge du patient.

Votre prochaine étape Rédigez dès aujourd'hui votre courrier de demande à partir du modèle ci-dessus, remplissez les crochets, joignez une copie de votre pièce d'identité, et postez-le en recommandé avec accusé de réception. Le délai de 8 jours ne commence à courir qu'à réception de cette demande : plus tôt vous l'envoyez, plus tôt vous disposez de vos pièces.

Un appui, si vous le souhaitez

Réunir votre dossier vous rend autonome pour la première étape, celle des faits. Leur analyse, en revanche, demande un regard technique : repérer une pièce manquante, lire une courbe de surveillance, mesurer si les soins ont été conformes. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié au dommage corporel et à la responsabilité médicale, propose une consultation initiale gratuite de 30 minutes pour faire le point sur votre situation, sans engagement. Vous restez libre de la suite.

Standard : 04 90 54 58 10. Site : <https://lexvox-victime.com>. Bureaux en PACA : Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles, Marignane.

DOCUMENT 02

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

La chronologie des soins

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre pourquoi une chronologie datée de vos soins est la première pièce que réclament un avocat et un médecin-conseil. - Remplir vous-même, ligne par ligne, un tableau clair qui reconstitue tout votre parcours médical, du premier rendez-vous à aujourd'hui. - Repérer les moments sensibles de votre prise en charge, sans les qualifier vous-même, grâce à un exemple entièrement rédigé.

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Pourquoi la chronologie change tout

Quand une prise en charge médicale se passe mal, vous gardez d'abord des souvenirs. Une douleur, une inquiétude, une phrase entendue dans un couloir. Ces souvenirs comptent, mais ils ne suffisent pas. Un dossier de responsabilité médicale se construit sur des faits datés, pas sur des impressions. La chronologie des soins transforme votre vécu en une matière que le droit et la médecine peuvent examiner.

Une chronologie, c'est simplement la liste ordonnée de tout ce qui vous est arrivé, dans l'ordre du calendrier. Chaque ligne porte une date, un lieu, un professionnel et un acte. Mise bout à bout, cette liste raconte votre parcours mieux que n'importe quel récit. Elle montre ce qui a été fait, quand, par qui, et ce qui a changé pour vous ensuite.

Cette pièce est la colonne vertébrale de l'expertise médicale. L'expertise médicale est l'examen conduit par un médecin, souvent désigné par une commission ou par un juge, pour évaluer vos lésions, vos séquelles et le lien entre vos soins et votre état. L'expert ne connaît pas votre histoire. Il la reconstitue à partir de pièces. Une chronologie claire lui fait gagner un temps précieux et l'empêche d'oublier un épisode important.

Elle sert aussi votre avocat et votre médecin-conseil. Le médecin-conseil est le médecin qui vous assiste, discute l'évaluation de vos préjudices et lit votre dossier avec un œil technique. Lui et votre avocat cherchent une chose : le manquement possible, c'est-à-dire l'acte ou l'absence d'acte qui n'aurait pas dû se produire. Ce manquement se cache toujours dans un intervalle de temps. Un retard de diagnostic, un signe négligé, une information non donnée. Sans dates précises, ces intervalles restent invisibles.

La loi elle-même raisonne en dates. En matière de responsabilité médicale, les actions se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage, selon l'article L1142-28 du code de la santé publique. La consolidation est le moment où votre état de santé se stabilise et n'évolue plus. Savoir dater vos épisodes de soins vous aide à situer ce point de départ et à ne pas laisser filer un délai.

Enfin, la chronologie protège votre mémoire. Les mois passent, les visages se confondent, les ordonnances se perdent. Un dossier médical peut compter des centaines de pages. En posant chaque fait sur une ligne datée dès maintenant, vous fixez la vérité pendant qu'elle est encore fraîche. Vous vous épargnez, plus tard, l'épuisement de tout reconstituer sous pression.

Le tableau à remplir, colonne par colonne

Voici l'outil. Un simple tableau à six colonnes, que vous complétez une ligne par événement. Un événement, c'est un rendez-vous, une hospitalisation, un examen, une opération, un appel, la remise d'une ordonnance. Notez tout, même ce qui vous semble mineur. Un détail anodin pour vous peut être décisif pour un médecin-conseil.

DATE	LIEU	PRATICIEN	ACTE RÉALISÉ	INFORMATION REÇUE	VOTRE ÉTAT APRÈS L'ACTE
Le jour, le mois, l'année. Ajoutez l'heure si vous la connaissez.	L'établissement ou le cabinet, avec la ville.	Le nom et la spécialité, si vous les avez.	Ce qui a été fait : consultation, examen, opération, prescription.	Ce que le professionnel vous a dit, expliqué, ou remis par écrit.	Comment vous vous sentiez ensuite : douleur, fièvre, amélioration, aggravation.

Chaque colonne a une raison d'être précise. Prenez le temps de comprendre ce qu'elle sert, car c'est ce qui distingue une chronologie utile d'une simple liste.

La date. C'est le cœur du tableau. Une date exacte vaut mieux qu'une approximation, mais une approximation vaut mieux que rien. Si vous hésitez, écrivez «vers le 12 mars» plutôt que de laisser vide. Vos justificatifs vous aideront à préciser ensuite. Regardez vos ordonnances, vos comptes rendus, vos relevés de sécurité sociale et vos messages : ils sont tous datés.

Le lieu. Un même parcours passe souvent par plusieurs établissements. La clinique où l'on vous a opéré, le cabinet de ville qui suit, le service d'urgences où vous êtes retourné. Distinguer les lieux permet de savoir qui détenait votre dossier à chaque étape, et à qui adresser une demande de communication.

Le praticien. Notez le nom quand vous le connaissez, sinon la fonction : «l'anesthésiste», «le chirurgien de garde», «l'infirmière du service». La responsabilité en médecine est personnelle ou attachée à un établissement. Savoir qui a fait quoi est donc essentiel, sans que vous ayez à désigner un coupable.

L'acte réalisé. Décrivez sobrement le geste ou la décision. «Pose d'une prothèse de hanche droite». «Prescription d'un antibiotique». «Radiographie de contrôle». Vous n'avez pas à employer le vocabulaire médical exact. Vos mots suffisent, votre médecin-conseil traduira.

L'information reçue. Cette colonne est souvent la plus négligée, et pourtant l'une des plus importantes. Notez ce qu'on vous a dit des risques, des alternatives, des suites attendues. La loi impose au professionnel de vous informer, et c'est à lui de prouver qu'il l'a fait, selon l'article L1111-2 du code de la santé publique. Ce que vous consignez ici, à chaud, éclaire plus tard une question délicate : avez-vous été préparé à ce qui est arrivé.

Votre état après l'acte. Décrivez ce que vous avez ressenti dans les heures et les jours qui ont suivi. Une fièvre, une douleur nouvelle, un écoulement, une gêne qui s'installe. C'est cette colonne qui fait apparaître les enchaînements. Un acte, puis un signe, puis un autre acte. La médecine et le droit lisent votre histoire dans ces enchaînements.

Un conseil de méthode. Remplissez le tableau au calme, en plusieurs fois, avec vos documents sous les yeux. Ne cherchez pas à interpréter. Vous décrivez, vous ne jugez pas. La qualification viendra plus tard, et elle appartient à d'autres. Votre travail, précieux, est de rendre les faits complets et exacts.

Où retrouver vos dates

La date exacte vous semble parfois perdue. Elle ne l'est presque jamais. Votre parcours a laissé partout des traces datées, et il suffit de les rassembler. Voici les sources les plus fiables, à réunir avant de remplir le tableau.

Vos ordonnances portent la date de chaque consultation et le nom du prescripteur. Vos comptes rendus d'hospitalisation et opératoires indiquent les dates d'entrée, d'intervention et de sortie. Vos résultats d'analyses et vos comptes rendus d'imagerie sont horodatés au jour près. Vos convocations, vos courriers entre médecins et vos bulletins de situation complètent l'ensemble.

Deux sources sont souvent oubliées, alors qu'elles sont très sûres. Vos relevés de l'assurance maladie, consultables sur votre compte, listent chaque acte remboursé avec sa date et le professionnel concerné. Vos agendas, vos messages et vos courriels contiennent des rappels de rendez-vous qui confirment une date hésitante.

Réunissez ces pièces dans un dossier unique, papier ou numérique, et numérotez-les. Cette organisation vous servira deux fois : d'abord pour dater votre chronologie, ensuite pour la transmettre à votre avocat sans rien avoir à rechercher dans l'urgence. Ne jetez jamais un document médical, même ancien, même illisible à vos yeux. Un compte rendu que vous ne comprenez pas peut être une pièce maîtresse pour un médecin-conseil.

Si des pièces vous manquent, vous pouvez réclamer votre dossier médical complet à chaque établissement. La marche à suivre fait l'objet d'un autre document du kit. Ne bloquez pas votre chronologie pour autant : commencez avec ce que vous avez, et complétez au fur et à mesure que les documents arrivent.

Un exemple entièrement rédigé : l'infection après une prothèse de hanche

Pour rendre l'outil concret, voici une chronologie complète. Elle est fictive, mais construite comme un vrai dossier. Les noms, les dates et les lieux sont illustratifs. Suivez le fil : une patiente, Madame Martin, se fait poser une prothèse de hanche, puis développe une infection. Observez comment le tableau fait remonter les moments qui méritent une question.

DATE	LIEU	PRATICIEN	ACTE RÉALISÉ	INFORMATION REÇUE	VOTRE ÉTAT APRÈS L'ACTE
8 janvier 2026	Cabinet d'orthopédie, Aix-en-Provence	Dr A., chirurgien orthopédiste	Consultation pour douleurs de hanche. Diagnostic d'arthrose évoluée. Indication d'une prothèse totale de hanche droite.	«L'opération est très courante. Vous marcherez mieux.» Aucun risque particulier détaillé par écrit.	Soulagée par la perspective, mais douleur quotidienne persistante.
22 janvier 2026	Laboratoire, Aix-en-Provence	Infirmière préleveuse	Bilan sanguin préopératoire.	Résultats à apporter le jour de l'hospitalisation.	Aucun changement.
5 février 2026	Clinique du Parc, Aix-en-Provence	Dr B., anesthésiste	Consultation d'anesthésie obligatoire.	Explications sur l'anesthésie. Remise d'un document sur le jeûne.	Aucun changement.
3 mars 2026	Clinique du Parc, Aix-en-Provence	Dr A., chirurgien	Pose de la prothèse totale de hanche droite. Intervention notée sans incident au compte rendu.	«Tout s'est bien passé.»	Douleur post-opératoire attendue. Fièvre légère le soir même.
4 mars 2026	Clinique du Parc, Aix-en-Provence	Infirmières du service	Surveillance, pansement, premier lever.	Consignes de rééducation.	Douleur vive. Température à 38,2 degrés notée au dossier.
6 mars 2026	Clinique du Parc, Aix-en-Provence	Dr A., chirurgien	Visite avant la sortie.	«La fièvre est normale après une opération.» Sortie autorisée.	Cicatrice rouge, chaude. Fièvre persistante à la maison.
12 mars 2026	Cabinet de ville, Salon-de-Provence	Médecin traitant	Consultation pour fièvre et écoulement de la cicatrice.	«Cela peut arriver.» Prescription d'un antibiotique par la bouche.	Écoulement clair par la cicatrice. Fièvre à 38,5 degrés.
19 mars 2026	Cabinet de ville, Salon-de-Provence	Médecin traitant	Consultation de contrôle. État non amélioré.	Conseil de contacter le chirurgien.	Douleur croissante, difficulté à poser le pied.
21 mars 2026	Clinique du Parc, Aix-en-Provence	Dr A., chirurgien	Examen de la cicatrice. Prélèvement de l'écoulement pour analyse.	«On attend les résultats du laboratoire.»	Fièvre à 39 degrés le lendemain.
24 mars 2026	Laboratoire de la clinique	Biologiste	Analyse du prélèvement. Identification d'un staphylocoque doré.	Résultat transmis au chirurgien.	État général altéré, frissons.

DATE	LIEU	PRATICIEN	ACTE RÉALISÉ	INFORMATION REÇUE	VOTRE ÉTAT APRÈS L'ACTE
25 mars 2026	Centre hospitalier, Marseille	Dr C., service des maladies infectieuses	Hospitalisation en urgence. Diagnostic d'infection du site opératoire sur prothèse.	«L'infection touche la prothèse. Une reprise chirurgicale est nécessaire.»	Alitée, sous antibiotiques par perfusion.
28 mars 2026	Centre hospitalier, Marseille	Dr D., chirurgien orthopédiste	Première reprise chirurgicale : lavage articulaire, prélèvements profonds.	«Nous nettoyons, nous gardons la prothèse pour l'instant.»	Douleur intense, hospitalisation prolongée.
15 avril 2026	Centre hospitalier, Marseille	Dr D., chirurgien orthopédiste	Seconde reprise : ablation de la prothèse infectée, pose d'un espaceur.	Explication d'une seconde prothèse dans plusieurs mois.	Perte d'autonomie, marche impossible sans aide.
2 mai 2026	Centre hospitalier, Marseille	Équipe soignante	Sortie avec antibiotiques prolongés et aide à domicile.	Rendez-vous de suivi programmés.	Autonomie très réduite, moral atteint, aide humaine quotidienne.

Cette chronologie tient sur une page. Elle raconte pourtant quatre mois d'une vie bouleversée. Lisez-la maintenant comme le ferait un médecin-conseil.

Plusieurs points appellent une question, sans qu'aucun ne soit, à ce stade, la preuve d'une faute. C'est justement ce que la chronologie permet : voir où regarder.

Le premier point sensible apparaît le 8 janvier. La colonne «information reçue» ne mentionne aucune explication écrite des risques, notamment le risque d'infection. Or l'infection est un risque connu de la chirurgie prothétique. La loi impose au professionnel d'informer le patient des risques graves normalement prévisibles, et c'est à lui de prouver qu'il l'a fait. Le défaut d'information, lorsqu'il existe, peut ouvrir droit à la réparation d'un préjudice propre, appelé préjudice d'impréparation. La Cour de cassation l'a consacré dans un arrêt de principe du 23 janvier 2014. Ce n'est pas à vous de trancher. Vous notez simplement l'absence, et vous laissez le juriste l'apprécier.

Le deuxième point sensible se lit dans l'enchaînement des 3, 4 et 6 mars. Une fièvre le soir de l'opération, une température élevée le lendemain, une cicatrice rouge et chaude à la sortie. Puis une sortie autorisée malgré ces signes. Un médecin-conseil se demandera si ces signaux d'alerte ont été correctement interprétés, ou si une surveillance plus longue s'imposait. La chronologie ne répond pas à cette question. Elle la rend visible.

Le troisième point sensible court du 12 au 24 mars. Presque deux semaines s'écoulent entre les premiers signes d'infection et l'identification du germe. Ce délai peut être médicalement justifié, ou non. Seule l'analyse du dossier complet le dira. Mais sans chronologie datée, ce délai passerait inaperçu. Avec elle, il saute aux yeux.

Le quatrième point touche la nature même de l'infection. Une infection contractée à l'occasion des soins, qui n'existait pas avant l'entrée dans l'établissement, porte un nom précis : l'infection nosocomiale. En droit, les établissements de santé répondent des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la

preuve d'une cause étrangère, selon l'article L1142-1 du code de la santé publique. C'est un régime particulier, plus favorable à la victime que la faute classique. Savoir dater précisément l'apparition de l'infection, après l'opération et non avant, devient alors déterminant. Votre chronologie fournit exactement cette datation.

Voyez ce que l'outil a produit. Une patiente qui gardait des souvenirs douloureux dispose maintenant d'une pièce solide. Elle n'a accusé personne. Elle a décrit. Et sa description, à elle seule, indique à son avocat et à son médecin-conseil les quatre endroits précis où creuser.

Ce que la chronologie ne fait pas

Il faut être clair, car votre prudence vous protège. La chronologie prépare votre dossier. Elle ne le juge pas. Repérer un point sensible n'est pas prouver une faute. Un délai peut avoir une explication médicale légitime. Une fièvre peut être banale. Une information non écrite a pu être donnée oralement.

La qualification d'une faute est un travail technique et juridique. Elle suppose de confronter votre chronologie au dossier médical complet, aux données de la science et aux règles de responsabilité. Ce travail revient à un avocat, épaulé par un médecin-conseil. Eux seuls peuvent dire si un manquement existe, s'il vous a causé un dommage, et selon quel fondement le faire valoir.

Cette répartition des rôles est une force, pas une limite. Vous apportez la matière première, précise et honnête. Les professionnels apportent l'analyse. Une chronologie exacte mais neutre a bien plus de poids qu'un récit accusateur et flou. Résistez donc à la tentation d'ajouter des commentaires ou des conclusions dans votre tableau. Laissez les faits parler.

Pour bâtir cette chronologie, vous aurez besoin de votre dossier médical. La loi vous en garantit l'accès. Toute personne peut obtenir communication des informations de santé la concernant, au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande, ce délai étant porté à 2 mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans, selon l'article L1111-7 du code de la santé publique. Ce dossier confirmera et complètera vos souvenirs. Un autre document du kit vous guide, pas à pas, pour le demander.

Enfin, une voie amiable existe avant tout procès. Toute personne s'estimant victime d'un dommage lié à des soins peut saisir une commission de conciliation et d'indemnisation, la CCI, dont la saisine suspend les délais de prescription, selon l'article L1142-7 du code de la santé publique. Là encore, votre chronologie sera la première pièce utile. Mais le choix de cette voie, comme celui d'un procès, se décide avec un avocat.

Lexique des termes employés

Chronologie des soins. Liste ordonnée et datée de tous les événements de votre parcours médical, du premier rendez-vous à aujourd'hui, qui sert de base à l'analyse de votre dossier.

Consolidation. Moment où votre état de santé se stabilise et n'évolue plus, à partir duquel on mesure les séquelles définitives et d'où court le délai de prescription.

Expertise médicale. Examen conduit par un médecin désigné, souvent par une commission ou un juge, pour évaluer vos lésions, vos séquelles et le lien entre vos soins et votre état.

Imputabilité. Lien de cause à effet entre un acte de soin et votre dommage, que le médecin-conseil et l'expert cherchent à établir à partir des faits datés.

Infection nosocomiale. Infection contractée à l'occasion des soins, absente avant votre prise en charge, dont l'établissement répond sauf s'il prouve une cause étrangère.

Médecin-conseil. Médecin qui vous assiste, lit votre dossier avec un regard technique et discute l'évaluation de vos préjudices, en face du médecin de l'assureur ou de l'expert.

Préjudice d'impréparation. Préjudice propre né du défaut d'information sur un risque, lorsque ce risque se réalise et que vous n'y aviez pas été préparé, reconnu par la Cour de cassation.

Prescription. Délai au-delà duquel une action n'est plus recevable. En responsabilité médicale, il est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage.

CCI (commission de conciliation et d'indemnisation). Instance amiable que peut saisir toute personne s'estimant victime d'un dommage lié aux soins, dont la saisine suspend les délais de prescription.

Votre prochaine étape Ouvrez un tableau vierge à six colonnes et posez dès aujourd'hui les dates dont vous êtes certain, en vous appuyant sur vos ordonnances et vos comptes rendus. Complétez le reste au fil de vos documents.

Un accompagnement si vous le souhaitez

Une fois votre chronologie posée, une lecture par des professionnels lui donne toute sa valeur. La SELARL LEXVOX AVOCATS, dont Me Patrice Humbert est spécialiste du dommage corporel, accompagne les victimes d'accidents médicaux dans toute la région PACA, avec une première consultation de 30 minutes gratuite. Si un moment de votre parcours vous interroge, vous pouvez nous en parler avant d'engager quoi que ce soit.

DOCUMENT 03

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

Le journal des symptômes et séquelles

Kit Erreur médicale LEXVOX, palier 1 (gratuit), document 1.3.

Ce que ce document va vous permettre - Consigner chaque jour, au bon format, vos douleurs, vos séquelles et leur retentissement sur votre vie quotidienne et professionnelle, pour que ces faits datés nourrissent plus tard l'évaluation de vos préjudices. - Disposer d'un modèle quotidien et d'une synthèse hebdomadaire prêts à remplir, simples à tenir même les jours difficiles. - Garder la trace, dans une section dédiée, des risques et des alternatives dont on ne vous avait pas parlé, au service du défaut d'information et du préjudice d'impréparation.

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Pourquoi tenir ce journal change votre dossier

Après un accident médical, votre mémoire s'use plus vite que vous ne le croyez. Les douleurs des premières semaines s'effacent dès qu'elles s'atténuent. Les nuits sans sommeil se confondent. Les gestes devenus impossibles finissent par sembler normaux, tant on s'y habitue. Or c'est précisément ce quotidien qui, le jour de l'expertise, servira à mesurer ce que vous avez subi.

L'évaluation de vos préjudices ne repose pas sur une impression générale. Elle repose sur des faits, situés dans le temps, décrits avec précision. Un expert qui vous examine plusieurs mois ou plusieurs années après les faits ne peut pas deviner l'intensité de vos douleurs passées. Il s'appuie sur les pièces médicales et sur ce que vous êtes capable de documenter. Un journal tenu jour après jour transforme votre vécu en preuve utilisable.

Cette réalité a un poids concret. Les offres spontanées des assureurs sont fréquemment 2 à 5 fois inférieures à l'indemnisation réelle obtenue avec un avocat spécialisé. L'écart se comble avec des éléments datés et vérifiables, pas avec des souvenirs. Votre journal est l'un de ces éléments, et c'est l'un des rares que vous maîtrisez entièrement.

Avant d'aller plus loin, un mot de vocabulaire. La **consolidation** est le moment où votre état de santé se stabilise, où les soins ne l'améliorent plus de façon notable. C'est à partir de cette date que se chiffre définitivement votre préjudice. Tout ce que vous consignez avant elle documente le chemin parcouru, et ce chemin compte autant que le point d'arrivée.

Les préjudices que votre journal vient nourrir

Les postes de préjudice corporel sont recensés par la nomenclature Dintilhac, un rapport de référence de juillet 2005 qui sert d'outil commun aux avocats, aux magistrats et aux médecins experts. Ce n'est pas une loi, mais c'est la grille que tout le monde utilise. Trois postes, en particulier, se nourrissent directement de ce que vous notez au quotidien.

Le **déficit fonctionnel temporaire**, souvent abrégé DFT, désigne la gêne dans les actes de la vie courante que vous subissez avant la consolidation, c'est-à-dire la réduction de votre autonomie, de vos capacités et de votre qualité de vie pendant la période de soins. Un mois passé alité, une main immobilisée, l'impossibilité de vous laver seul : tout cela relève du DFT. Il s'évalue en durée et en intensité, d'où l'intérêt de dater précisément le début et la fin de chaque gêne.

Les **souffrances endurées** désignent toutes les douleurs physiques et les souffrances psychiques que vous éprouvez depuis l'accident médical jusqu'à la consolidation. On les cote sur une échelle de 1 à 7 lors de l'expertise. Cette cotation gagne à s'appuyer sur une trace concrète : l'intensité de vos douleurs jour après jour, les traitements antalgiques, les réveils nocturnes, l'angoisse avant une nouvelle intervention. Un chiffre noté chaque soir vaut mieux qu'une estimation rétrospective.

Le **préjudice d'agrément** désigne l'impossibilité, ou la difficulté, de pratiquer régulièrement une activité de loisir ou de sport que vous exerciez avant l'accident médical. Il ne se présume pas : il faut établir que vous couriez, jardiniez,

jouiez d'un instrument, et que vous ne le pouvez plus, ou plus comme avant. Consigner les activités que vous avez dû abandonner, avec leur date d'arrêt, prépare la démonstration de ce poste.

À ces trois postes s'ajoute une dimension propre au contentieux médical. Le journal permet aussi de garder la mémoire de ce qu'on ne vous avait pas dit avant le geste, sujet auquel une section entière de ce document est consacrée plus bas. Sur ce terrain, la charge de la preuve pèse d'ailleurs sur le professionnel de santé. L'article L1111-2 du code de la santé publique consacre votre droit à l'information, et en cas de litige, c'est au médecin ou à l'établissement de prouver qu'il vous l'a bien délivrée.

Voici la citation exacte de l'article L1111-2 du code de la santé publique (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137408) :

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. »

Comment tenir ce journal, sans vous épuiser

Quelques règles simples suffisent à rendre votre journal solide.

Écrivez chaque jour, même brièvement. Trois lignes valent mieux qu'une page rédigée de mémoire une fois par mois. La régularité est ce qui donne de la valeur à l'ensemble. Un jour manqué n'est pas grave, mais reprenez dès le lendemain.

Restez factuel. Notez ce que vous ressentez et ce que vous ne pouvez pas faire, sans dramatiser ni minimiser. Un journal sincère, où alternent les bons et les mauvais jours, est plus crédible qu'un récit uniformément noir. Les jours où cela va mieux méritent aussi d'être notés : ils montrent que vous ne cherchez pas à exagérer.

Datez tout. Chaque entrée porte sa date. C'est la datation qui distingue une preuve d'une simple plainte.

Chiffrez ce qui peut l'être. Une douleur cotée de 0 à 10, une aide mesurée en minutes, un nombre de réveils nocturnes : ces chiffres, additionnés sur des semaines, dessinent une réalité qu'aucun mot seul ne rend.

Restez loyal. Ne notez que des faits vous concernant, dans un carnet qui est le vôtre. Ne cherchez jamais à enregistrer un soignant à son insu ni à fabriquer une preuve : un procédé déloyal se retourne contre la victime. Votre journal tire sa force de sa sincérité, pas d'un stratagème.

Conservez une copie. Photographiez ou scannez régulièrement vos pages, et rangez ces fichiers dans un dossier dédié. Un carnet perdu ne se reconstitue pas.

Le modèle quotidien à remplir

Reproduisez ce cadre chaque soir, sur un carnet papier ou dans une note numérique. Il se remplit en quelques minutes. L'important n'est pas la longueur, mais la constance et la précision des chiffres.

Journal du jour

Date : Jour de la semaine :

1. Douleur. Note globale de 0 (aucune douleur) à 10 (douleur maximale imaginable) : Localisation principale (où avez-vous mal aujourd'hui) : Moment le plus douloureux de la journée :

..... Traitement antalgique pris (nom, nombre de prises) :

2. Sommeil. Nombre d'heures dormies : Nombre de réveils dans la nuit : Réveils liés à la douleur : oui / non. Qualité du sommeil de 0 (très mauvais) à 10 (excellent) :

3. Actes pénibles ou impossibles aujourd'hui. Cochez et précisez. ☐ Me laver, faire ma toilette. Précision :

..... ☐ M'habiller seul. Précision : ☐ Préparer un repas, manger.

Précision : ☐ Me déplacer dans le logement, monter un escalier. Précision :

..... ☐ Sortir, faire une course, conduire. Précision : ☐ M'occuper de mes enfants ou d'un proche. Précision :

☐ Autre acte du quotidien :

.....

4. Aide reçue aujourd'hui. Qui vous a aidé, pour quel geste, combien de temps. Personne : Tâche :

Durée en minutes : Personne : Tâche : Durée en minutes : Total d'aide reçue dans la journée (en minutes) :

5. Moral. Note de 0 (très mauvais) à 10 (très bon) : En un mot ou deux, votre état d'esprit du jour :

..... Anxiété liée à un rendez-vous ou à une intervention à venir : oui / non.

6. Activités que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Loisir, sport, sortie, engagement. Sur le plan de la vie personnelle et intime, le retentissement du jour, décrit avec pudeur et en vos propres mots (vous restez libre de n'écrire qu'une lettre ou un signe repère si vous préférez) :

Un mot sur la dernière ligne. Le retentissement sur la vie intime et affective est un préjudice réel et reconnu. Vous n'avez pas à entrer dans des détails qui vous mettent mal à l'aise. Une formulation sobre suffit, par exemple « intimité impossible ce jour » ou un simple repère que vous seul comprenez. Ce qui compte est la trace datée, pas la crudité du récit. Vous pourrez, le moment venu, en parler à votre avocat dans un cadre confidentiel.

Le modèle hebdomadaire de synthèse

Une fois par semaine, prenez cinq minutes pour relire vos sept fiches et en tirer une vue d'ensemble. Cette synthèse est précieuse : elle transforme une accumulation de détails en tendances lisibles, celles-là mêmes qu'un expert cherche à saisir.

Synthèse de la semaine

Semaine du au (numéro de semaine depuis l'accident médical :)

Douleur. Note la plus basse de la semaine : Note la plus haute : Moyenne approximative : Localisation la plus fréquente :

Sommeil. Nombre de nuits vraiment reposantes : Nombre de nuits difficiles : Total approximatif de réveils nocturnes sur la semaine :

Autonomie. Les trois actes du quotidien les plus difficiles cette semaine : 1. 2. 3. Un acte que je peux à nouveau faire, s'il y a une amélioration :

Aide humaine. Total d'aide reçue sur la semaine (additionnez les minutes des sept jours) : minutes. Personnes qui vous ont aidé le plus souvent :

Moral. Tendance de la semaine : en amélioration / stable / en dégradation. Événement marquant, bon ou mauvais :

Vie sociale, loisirs, travail. Activités ou engagements manqués cette semaine : Répercussion sur votre activité professionnelle (arrêt, aménagement, fatigue au poste) :

Rendez-vous et soins de la semaine. Consultations, examens, séances de rééducation : Question restée sans réponse, à poser au prochain rendez-vous :

Cette synthèse a un autre mérite. Le total hebdomadaire d'aide humaine, en minutes, prépare la démonstration du besoin d'aide d'une tierce personne, c'est-à-dire l'assistance d'un proche ou d'un professionnel pour les gestes que vous ne pouvez plus accomplir seul. Ce poste est souvent l'un des plus élevés d'un dossier, et il se prouve par des heures documentées, pas par une estimation faite après coup.

Section spécifique : les informations que l'on ne m'avait pas données

Cette section est propre au contentieux médical. Elle mérite une page à part dans votre carnet, car elle sert un terrain juridique distinct de vos douleurs : celui de l'information que vous auriez dû recevoir avant le geste, et que vous n'avez pas reçue.

Le raisonnement est le suivant. Avant une intervention ou un traitement, le professionnel de santé doit vous informer des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, des alternatives possibles et des conséquences d'un refus. C'est l'exigence posée par l'article L1111-2 cité plus haut. Lorsque cette information manque et qu'un risque non annoncé se réalise, deux préjudices distincts peuvent naître.

Le premier est le **préjudice d'impréparation**, que l'on peut définir ainsi : c'est le préjudice moral subi par le patient qui, faute d'avoir été informé d'un risque, n'a pas pu s'y préparer psychologiquement lorsque ce risque s'est réalisé. La Cour de cassation en a fait un préjudice autonome, réparable en lui-même, indépendamment de toute perte de chance d'avoir évité l'acte.

Voici la citation exacte de l'arrêt de principe, Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.123 (<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413>) :

« le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation »

Cette solution a été confirmée depuis. La Cour de cassation, 1re chambre civile, dans son arrêt du 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898 (<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033943617>), a rappelé qu'il s'agit d'« un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé ».

Le second terrain est celui du **défaut d'information** lui-même, ce manquement du professionnel à son obligation de vous renseigner. Puisque c'est à lui de prouver qu'il vous a informé, tout ce que vous consignez sur ce que vous ignoriez vient éclairer le débat. Vos notes ne remplacent pas cette preuve, mais elles fixent votre version des faits au plus près du moment où ils se sont produits.

D'où l'intérêt de tenir, à froid, la liste de ce dont on ne vous a jamais parlé. Remplissez le cadre ci-dessous dès que vous découvrez, souvent après coup, un risque ou une alternative dont personne ne vous avait informé.

Ce que l'on ne m'avait pas dit

Date à laquelle je l'ai découvert : **Comment je l'ai appris (nouveau médecin, notice, dossier médical, proche) :**

1. Le risque ou la complication qui s'est réalisé : M'en avait-on parlé avant le geste : oui / non / je ne m'en souviens pas. Un document d'information ou de consentement m'a-t-il été remis et signé : oui / non / je ne sais pas.

2. Les alternatives que l'on ne m'a pas proposées : (Autre traitement, autre technique, possibilité d'attendre, possibilité de refuser.)

3. Ce que j'aurais fait si j'avais su : (Décrire honnêtement : accepter quand même, demander un second avis, refuser, différer.)

4. Comment j'ai vécu la découverte que je n'avais pas été prévenu : (Le choc de l'impréparation, le sentiment de ne pas avoir choisi en connaissance de cause.)

Ne cherchez pas à qualifier juridiquement vous-même ces éléments. Contentez-vous de décrire ce que vous saviez, ce que vous ne saviez pas, et à quel moment vous l'avez appris. Le tri entre défaut d'information, préjudice d'impréparation et éventuelle perte de chance relève de l'analyse de votre avocat, à partir de la matière que vous aurez rassemblée.

Un petit lexique pour ce document

- **Consolidation** : moment où votre état de santé se stabilise et où les soins ne l'améliorent plus de façon notable ; point de départ du chiffrage définitif.
- **Déficit fonctionnel temporaire (DFT)** : gêne dans les actes de la vie courante subie avant la consolidation, évaluée en durée et en intensité.
- **Souffrances endurées** : douleurs physiques et souffrances psychiques éprouvées de l'accident médical jusqu'à la consolidation, cotées de 1 à 7.
- **Préjudice d'agrément** : impossibilité ou difficulté de pratiquer régulièrement une activité de loisir ou de sport exercée avant l'accident médical.
- **Tierce personne** : aide d'un proche ou d'un professionnel pour les gestes que vous ne pouvez plus accomplir seul.
- **Défaut d'information** : manquement du professionnel de santé à son obligation de vous informer des risques, des alternatives et des conséquences d'un refus.
- **Préjudice d'impréparation** : préjudice moral du patient qui, faute d'information, n'a pas pu se préparer psychologiquement à un risque qui s'est réalisé.

Votre prochaine étape

Procurez-vous dès aujourd'hui un carnet dédié, inscrivez la date en tête de la première page et remplissez ce soir votre première fiche quotidienne. Le plus difficile est de commencer : à partir de demain, il ne s'agit plus que de continuer.

Un mot du cabinet

Tenir ce journal demande de la constance, dans une période où l'énergie manque souvent. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié au dommage corporel et à la responsabilité médicale, accompagne les victimes d'accident médical dans la construction de leur dossier. Une consultation initiale gratuite de 30 minutes permet de faire le point sur les éléments réunis et sur la façon de les valoriser. Vous pouvez joindre le standard au 04 90 54 58 10 ou nous retrouver sur <https://lexvox-victime.com>, dans nos quatre bureaux de Provence (Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles, Marignane).

Chemin : /home/user/lexvox-victime/kits/medical/palier-1/m1-3-journal-symptomes-sequelles.md Longueur approximative : 2 900 mots de texte rédigé, hors champs de saisie des modèles ; environ 8 pages une fois maqueté avec les fiches quotidienne et hebdomadaire à remplir. Références citées (referentiel-verifie.json) : csp-L1111-2 (article L1111-2 du code de la santé publique, cité verbatim et par URL), cass-2014-12-22123-impreparation (Cass. 1re civ. 23 janvier 2014, n° 12-22.123, préjudice d'impréparation, cité verbatim et par URL), cass-2017-15-27898-impreparation (Cass. 1re civ. 25 janvier 2017, n° 15-27.898, confirmation, cité verbatim et par URL), dintilhac (nomenclature Dintilhac, outil de référence non normatif, cité pour les postes DFT, souffrances endurées et préjudice d'agrément). Preuves cabinet mobilisées : constat de pratique 2 à 5 fois, consultation gratuite de 30 minutes, coordonnées (BRIEF-REDACTION.md).

DOCUMENT 04

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

La carte des 3 voies

Kit Erreur médicale LEXVOX, palier 1 (gratuit), document 1.4.

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre les 3 chemins qui existent pour être indemnisé après un accident médical, et savoir lequel correspond à votre situation. - Comparer d'un coup d'œil le coût, la durée, les avantages et les limites de chaque voie, grâce à un tableau clair. - Reconnaître les 4 fondements de la responsabilité médicale et le délai qui vous est laissé pour agir, avant qu'il ne soit trop tard.

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Pourquoi une «carte» plutôt qu'une seule route

Quand un soin tourne mal, une question revient toujours : «Vers qui me tourner ?» La réponse déroute souvent les victimes, car il n'existe pas une porte unique, mais trois. Vous pouvez négocier directement avec l'assureur du praticien. Vous pouvez saisir une commission publique et gratuite. Vous pouvez enfin porter votre affaire devant un tribunal. Ces trois voies ne s'excluent pas toujours, et le bon choix dépend de la gravité de vos séquelles, de la nature de l'erreur et de vos moyens.

Ce document est votre carte. Il ne décide pas à votre place, mais il vous montre le terrain. Vous verrez que chaque voie a un prix, un rythme et une logique propres. Vous verrez surtout que ces routes reposent toutes sur les mêmes fondements juridiques et sur un même compte à rebours : celui de la prescription. Comprendre cette carte, c'est éviter de vous engager à l'aveugle dans un chemin qui ne vous convient pas.

Avant d'entrer dans le détail, fixons quelques mots. Ils reviendront à chaque page, et leur sens exact conditionne vos droits. Vous les retrouverez, définis en une phrase, dans le lexique final de ce document.

Voie 1. La voie amiable : la réclamation à l'assureur

La première voie est la plus directe. Tout professionnel de santé et tout établissement sont assurés pour leur responsabilité civile. Lorsque vous estimez avoir subi un dommage, vous pouvez adresser une réclamation écrite à cet assureur. Vous exposez les faits, vous joignez vos pièces médicales et vous demandez réparation. L'assureur instruit alors votre dossier, mandate le plus souvent son propre médecin-conseil, puis formule, ou refuse, une offre.

Cette voie a un mérite réel : sa souplesse. Aucune formalité lourde n'est exigée pour l'engager. Vous restez maître du calendrier et vous pouvez, à tout moment, l'interrompre pour emprunter une autre route. Elle convient bien aux dommages dont l'origine fautive est nette et facilement démontrable, ou lorsque le praticien lui-même reconnaît son erreur.

Elle a aussi une faiblesse structurelle. En face de vous se trouve une entreprise dont l'intérêt est de limiter le montant versé. L'expertise est organisée par l'assureur, avec son médecin. Rien ne vous garantit une évaluation complète de

tous vos postes de préjudice. C'est précisément là que l'écart se creuse : dans la pratique, les offres spontanées des assureurs sont fréquemment 2 à 5 fois inférieures à l'indemnisation réelle obtenue avec un avocat spécialisé. La voie amiable n'est donc pas à écarter, mais elle demande une vigilance constante, et rien ne vous oblige à accepter la première proposition.

Voie 2. La voie CCI : la commission de conciliation et d'indemnisation

La deuxième voie est sans doute la moins connue, et souvent la plus utile. Il s'agit de la commission de conciliation et d'indemnisation, la CCI. Créée pour les victimes d'accidents médicaux, elle offre une procédure gratuite. L'expertise médicale, cœur de tout dossier, y est prise en charge : vous n'avancez pas les honoraires de l'expert. C'est un avantage considérable, car cette expertise coûte cher dans les autres voies.

La CCI peut être saisie très largement. L'article L1142-7 du code de la santé publique le prévoit expressément : «La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins [...]. La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.» (source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721134).

Retenez la seconde phrase, car elle est décisive. Saisir la CCI met le chronomètre de la prescription en pause. Pendant toute la procédure, le délai qui vous menace ne court plus. Vous ne perdez donc pas votre droit d'aller ensuite devant un juge si la CCI ne vous satisfait pas. C'est un filet de sécurité précieux quand la fin du délai approche.

La CCI présente toutefois une condition d'accès stricte : votre dommage doit atteindre un certain seuil de gravité. En dessous, la commission est incompétente et votre demande sera écartée. L'article D1142-1 du code de la santé publique fixe le principal de ces seuils : «Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.» (source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023458773). Ce même texte ouvre aussi la voie, notamment, à la victime dont l'accident médical a entraîné un arrêt temporaire des activités professionnelles, ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 %, pendant 6 mois consécutifs ou non sur une période de 12 mois.

En clair, la CCI vise les dommages sérieux : une atteinte permanente d'au moins 24 %, ou une incapacité lourde et prolongée. Pour une séquelle légère, elle ne sera pas ouverte. À l'issue de la procédure, la commission rend un avis qui oriente l'indemnisation, soit vers l'assureur du responsable si une faute est retenue, soit vers l'ONIAM lorsque la solidarité nationale doit jouer.

Voie 3. La voie judiciaire : le tribunal

La troisième voie est celle du procès. Vous demandez à un juge de trancher, de désigner un expert judiciaire et de condamner le responsable à vous indemniser. C'est la voie la plus formelle, la plus longue et la plus coûteuse, mais aussi la plus puissante lorsque le dialogue est rompu ou lorsque les sommes en jeu sont importantes.

Un point technique est ici essentiel, et il déroute souvent les victimes : le tribunal compétent dépend de la nature de l'établissement où le soin a été délivré. Si l'erreur est survenue dans le secteur privé, chez un praticien libéral ou dans une clinique privée, vous relevez du tribunal judiciaire. Si elle est survenue dans le secteur public, dans un hôpital

public par exemple, vous relevez du tribunal administratif. Se tromper de tribunal fait perdre un temps précieux. Cette frontière entre le privé et le public commande toute la stratégie de votre dossier.

La voie judiciaire ouvre l'accès à une expertise indépendante, ordonnée par le juge et contradictoire, à laquelle votre propre médecin-conseil peut participer. Elle permet aussi d'obtenir des provisions, c'est-à-dire des avances, pendant que l'affaire se poursuit. Sa contrepartie est le coût et la durée. Les honoraires d'avocat et les frais d'expertise s'ajoutent, et la procédure s'étale sur plusieurs années. Le record obtenu par le cabinet, une indemnisation de 3 270 000 € contre l'ONIAM, l'a été après 8 ans de contentieux : la mesure des délais que peut exiger une affaire complexe.

Conformément à l'article 11.1 du Règlement Intérieur National, l'avocat est tenu à une obligation de moyens, non de résultat. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Chaque situation est unique.

La frontière du privé et du public, en pratique

La distinction entre secteur privé et secteur public mérite qu'on s'y arrête, car elle décide du tribunal, mais aussi du rythme et des règles applicables. Un même geste, pratiqué à l'identique, ne relève pas des mêmes juges selon le lieu où il a eu lieu.

Relèvent en principe du secteur privé : le médecin libéral installé en cabinet, le chirurgien exerçant à titre libéral, la clinique privée. Le contentieux se porte alors devant le tribunal judiciaire, celui du droit commun. Relèvent du secteur public : l'hôpital public, le centre hospitalier universitaire, l'établissement public de santé. Le litige se porte devant le tribunal administratif, avec ses propres règles de procédure et ses propres délais.

Cette frontière n'est pas toujours simple à tracer. Un praticien peut exercer une activité libérale au sein d'un hôpital public. Un patient peut être pris en charge successivement dans les deux secteurs. Une erreur d'aiguillage vous fait perdre des mois, le temps que le tribunal saisi à tort décline sa compétence. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est prudent de faire qualifier votre situation avant d'agir. La CCI, elle, présente ici un avantage : elle est compétente quel que soit le secteur, ce qui évite d'avoir à trancher cette question au tout début.

Retenez l'essentiel : la voie judiciaire n'est pas une porte unique, mais deux portes distinctes. Frapper à la bonne dès le départ fait gagner un temps que la prescription rend précieux.

Le tableau comparatif des 3 voies

Le tableau ci-dessous résume les différences essentielles. Il ne remplace pas une analyse de votre dossier, mais il vous aide à situer d'un coup d'œil la voie la plus adaptée. Les durées indiquées sont des ordres de grandeur observés en pratique, non des délais garantis, car chaque dossier a son rythme.

CRITÈRE	VOIE 1. AMIABLE (ASSUREUR)	VOIE 2. CCI	VOIE 3. JUDICIAIRE
Coût pour vous	Faible. Pas de frais de procédure, mais expertise organisée par l'assureur	Gratuit. Expertise médicale prise en charge	Élevé. Honoraires d'avocat et frais d'expertise judiciaire
Durée indicative	Variable, souvent quelques mois à 1 an	Encadrée, de l'ordre de plusieurs mois	Longue, plusieurs années
Expertise	Menée par le médecin-conseil de l'assureur	Prise en charge, expert désigné par la commission	Ordonnée par le juge, indépendante et contradictoire
Condition d'accès	Aucune formalité de seuil	Seuil de gravité requis (24 % d'AIPP, ou incapacité lourde de 6 mois)	Aucun seuil, mais bon tribunal à choisir (judiciaire ou administratif)
Effet sur la prescription	Sans effet suspensif automatique	Suspend la prescription et les recours contentieux	Interrompt le délai par l'action en justice
Avantage principal	Rapidité et souplesse	Gratuité, neutralité, filet de sécurité sur les délais	Force de la décision, expertise indépendante
Limite principale	Face à un assureur dont l'intérêt est de limiter l'offre	Fermée aux dommages légers sous le seuil	Coût et durée

Ce tableau fait apparaître une logique simple. La voie amiable privilégie la vitesse. La CCI privilégie la gratuité et la sécurité, mais réserve son accès aux dommages graves. La voie judiciaire privilégie la force, au prix du temps et de l'argent. Beaucoup de dossiers combinent ces voies dans le temps : une réclamation amiable d'abord, une saisine de la CCI ensuite, un procès en dernier recours. Le bon enchaînement se décide au cas par cas.

Comment choisir : 3 questions à vous poser

La carte ne sert que si vous savez lire votre propre position. Trois questions simples vous orientent vers la voie la plus adaptée. Elles ne remplacent pas l'avis d'un professionnel, mais elles clarifient votre réflexion.

Première question : quelle est la gravité de mes séquelles ? C'est le critère qui commande le plus vite. Si votre atteinte permanente atteint ou dépasse 24 %, ou si vous avez subi une incapacité lourde et prolongée, la porte de la CCI vous est ouverte, avec sa gratuité et son expertise prise en charge. En dessous de ce seuil, la CCI est fermée : il vous reste la voie amiable et, si le litige se durcit, la voie judiciaire. Ne vous auto-évaluez pas au jugé : le taux d'atteinte est fixé par une expertise médicale, et une séquelle que vous croyez mineure peut se révéler plus lourde une fois mesurée.

Deuxième question : la faute est-elle claire, ou s'agit-il d'un aléa ? Si l'erreur est nette et reconnue, la voie amiable peut aboutir vite. Si, au contraire, personne n'a fauté mais que le dommage est grave, votre chemin passe par la solidarité nationale et l'ONIAM, que la CCI est justement chargée d'actionner. Et si l'origine du dommage est disputée, si l'établissement nie tout manquement, seule une expertise indépendante, celle de la CCI ou celle du juge, tranchera utilement.

Troisième question : où en suis-je de mon délai ? Si votre consolidation est ancienne et que l'échéance des 10 ans approche, la priorité absolue est de suspendre ou d'interrompre la prescription. Saisir la CCI suspend le délai ; engager une action en justice l'interrompt. Dans ce cas, ne restez jamais dans la seule discussion amiable, qui n'arrête pas automatiquement le compte à rebours. Sécurisez d'abord vos droits, vous négociez ensuite.

Ces trois questions se combinent. Une victime dont les séquelles sont graves, dont l'origine du dommage est contestée et dont le délai file a tout intérêt à saisir la CCI sans attendre. Une victime dont l'erreur est reconnue et les séquelles modestes tentera d'abord l'amiable. Il n'existe pas de réponse unique, seulement la réponse qui correspond à votre situation.

Ce qu'il faut préparer avant d'emprunter une voie

Quelle que soit la route retenue, une même règle vaut : rien ne se joue sur vos souvenirs, tout se joue sur vos preuves écrites. Trois pièces forment le socle de n'importe quel dossier médical.

La première est votre dossier médical complet. Vous avez le droit d'en obtenir communication. Il contient les comptes rendus opératoires, les résultats d'examens, les prescriptions et les courriers entre praticiens. C'est la matière première de toute expertise.

La deuxième est la chronologie des faits, écrite de votre main : les dates, les symptômes, les paroles échangées, les décisions prises. Une chronologie précise, rédigée quand les souvenirs sont frais, vaut mieux qu'une reconstitution tardive.

La troisième est la trace de votre préjudice au quotidien : arrêts de travail, factures de soins, justificatifs de l'aide apportée par vos proches. Ces pièces nourrissent l'évaluation de vos postes de préjudice, quelle que soit la voie. Les rassembler tôt, c'est aborder chaque voie en position de force.

Les 4 fondements de la responsabilité médicale

Quelle que soit la voie choisie, votre demande doit reposer sur un fondement juridique. Le droit médical en connaît quatre. Ils découlent principalement de l'article L1142-1 du code de la santé publique, dont voici le passage central : «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé [...] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.» (source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252). Ce seul article pose déjà trois des quatre piliers. Reprenons-les un par un.

1. La faute

C'est le principe de base. Un professionnel de santé n'est responsable que s'il a commis une faute. Autrement dit, il faut démontrer que le soin, le diagnostic ou l'acte n'a pas été conforme aux règles de l'art. Un retard fautif de diagnostic, un geste chirurgical maladroit, une surveillance insuffisante : autant de fautes possibles. Sans faute, la responsabilité du praticien n'est en principe pas engagée. Cette exigence explique l'importance de l'expertise médicale, seule à même d'établir l'écart entre les soins reçus et les soins attendus.

2. L'aléa thérapeutique et la solidarité nationale

Tout dommage médical ne résulte pas d'une faute. Un acte peut être parfaitement réalisé et pourtant causer un préjudice grave : c'est l'aléa thérapeutique, aussi appelé accident médical non fautif. Le droit ne laisse pas la victime sans réponse. Lorsque cet accident non fautif atteint un certain degré de gravité, il est réparé au titre de la solidarité nationale, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM. Ce n'est plus un responsable qui paie, mais un fonds public. Ce mécanisme, prévu par l'article L1142-1 du même code, est une spécificité française : il indemnise la victime même quand personne n'a fauté.

3. L'infection nosocomiale

L'infection nosocomiale est celle que vous contractez à l'occasion de votre prise en charge, à l'hôpital ou en clinique. Ici, la logique s'inverse en votre faveur. L'établissement est responsable de plein droit, comme le prévoit l'article L1142-1 cité plus haut : il répond du dommage sans que vous ayez à prouver une faute, sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère. C'est un régime particulièrement protecteur.

Lorsque l'infection est très grave, la solidarité nationale prend le relais. L'article L1142-1-1 du code de la santé publique le prévoit : «ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % [...] ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.» (source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628248). Au-delà de 25 % d'atteinte permanente, ou en cas de décès, c'est donc l'ONIAM qui indemnise. Notez bien la nuance : le seuil d'accès à la CCI est de 24 %, tandis que le basculement de l'infection nosocomiale vers l'ONIAM se joue au-delà de 25 %. Ces deux chiffres, proches, ne se confondent pas.

4. Le défaut d'information

Le quatrième fondement est distinct des trois précédents. Avant tout acte, votre médecin doit vous informer. L'article L1111-2 du code de la santé publique le formule ainsi : «Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.» (source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137408).

Si cette information n'a pas été donnée et qu'un risque se réalise, vous subissez un préjudice propre, indépendant de toute maladresse technique. La Cour de cassation l'a consacré : «le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation» (Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.123, source : <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413>). Un point capital : la preuve que l'information a bien été délivrée pèse sur le professionnel, non sur vous.

Les délais : le compte à rebours de la prescription

Aucune de ces voies ne reste ouverte indéfiniment. Le droit fixe un délai au-delà duquel vous ne pouvez plus agir : c'est la prescription. En matière médicale, ce délai est de 10 ans. L'article L1142-28 du code de la santé publique le pose : «Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux [...] se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.» (source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033810165).

Deux enseignements en découlent. D'abord, le point de départ n'est pas la date du soin, mais la date de consolidation, c'est-à-dire le moment où votre état est stabilisé. Un dommage qui évolue longtemps repousse d'autant ce point de départ. Ensuite, ce délai de 10 ans peut être suspendu. C'est tout l'intérêt de la CCI, vu plus haut : sa saisine met la prescription en pause. Si l'échéance approche et que votre dossier n'est pas prêt, saisir la commission protège vos droits pendant que la procédure se déroule.

Un conseil de méthode s'impose. Ne présumez jamais qu'il vous «reste du temps». La date de consolidation se discute, elle n'est pas toujours évidente, et un dossier médical solide demande des mois de préparation. Plus vous agissez tôt, plus vos preuves sont fraîches et vos chances intactes.

Lexique des termes essentiels

Ce document a introduit un vocabulaire technique. Voici, en une phrase chacun, les mots à retenir. Gardez-les sous les yeux à chaque étape de votre dossier.

Consolidation. Moment médical où votre état est stabilisé et n'évolue plus, à partir duquel on peut mesurer définitivement les séquelles et chiffrer votre indemnisation ; c'est aussi le point de départ du délai de prescription de 10 ans.

ONIAM. Office national d'indemnisation des accidents médicaux, fonds public qui indemnise les victimes au titre de la solidarité nationale, notamment en cas d'accident médical non fautif grave ou d'infection nosocomiale au-delà de 25 % d'atteinte permanente.

CCI. Commission de conciliation et d'indemnisation, procédure publique et gratuite, avec expertise prise en charge, ouverte aux victimes d'accidents médicaux dont le dommage atteint le seuil de gravité requis.

Infection nosocomiale. Infection contractée à l'occasion de votre prise en charge dans un établissement de santé, dont l'établissement répond de plein droit, sauf s'il prouve une cause étrangère.

Aléa thérapeutique. Accident médical survenu sans faute, alors que les soins ont été conformes aux règles de l'art, et qui, s'il est assez grave, est réparé par la solidarité nationale via l'ONIAM.

AIPP. Atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, exprimée en pourcentage, qui mesure le retentissement durable de vos séquelles et sert de référence aux seuils de gravité.

Votre prochaine étape Repérez, dans votre dossier, la date de consolidation ou, à défaut, la date de vos derniers soins : c'est elle qui commande votre délai pour agir. Notez-la avant toute autre démarche.

Un accompagnement si vous le souhaitez

Choisir la bonne voie, au bon moment, sur le bon fondement, n'est pas une décision à prendre seul face à un assureur ou à un hôpital. La SELARL LEXVOX AVOCATS, dont Me Patrice Humbert est spécialiste du dommage corporel, accompagne les victimes d'accidents médicaux dans toute la région PACA, depuis ses bureaux d'Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane. La première consultation de 30 minutes est gratuite. Si vous hésitez entre l'amiable, la CCI et le tribunal, vous pouvez en parler avec nous avant de vous engager. Standard : 04 90 54 58 10. Site : <https://lexvox-victime.com>.

DOCUMENT 05

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

Les 10 signaux d'une possible erreur médicale

Ce que ce document va vous permettre

- Reconnaître, sans affolement, dix situations qui peuvent justifier de regarder votre parcours de soins de plus près.
- Comprendre pour chaque signal ce qu'il peut vouloir dire, ce qu'il ne prouve en aucun cas, et le geste utile à poser.
- Savoir documenter et conserver les bons éléments, pour qu'un avocat et un médecin-conseil puissent, s'il y a lieu, analyser votre dossier sereinement.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Avant tout : un signal n'est pas une preuve

Un soin qui se passe mal n'est pas forcément une faute. La médecine comporte des aléas, des complications connues, des risques qui se réalisent parfois sans que personne n'ait commis d'erreur. La loi elle-même distingue clairement la faute, qui engage la responsabilité du professionnel, de l'accident médical non fautif, qui relève d'un autre mécanisme. L'article L1142-1 du code de la santé publique pose ce principe : les professionnels de santé ne répondent des conséquences dommageables de leurs actes qu'en cas de faute.

Autrement dit, ressentir un doute est légitime, mais ce doute ne qualifie rien à lui seul. Seul un avocat en dommage corporel, épaulé par un médecin-conseil, peut dire si un manquement fautif existe, en confrontant votre dossier médical aux règles de l'art. Cette phrase reviendra tout au long de ce document, parce qu'elle est la clé de votre protection : elle vous évite autant les illusions que les renoncements.

Ce document présente dix signaux. Aucun ne vaut accusation. Chacun est simplement une invitation à documenter et à faire examiner votre parcours par des professionnels. Pour chaque signal, vous trouverez trois éléments : ce qu'il peut signifier, ce qu'il ne prouve pas, et ce qu'il faut faire.

Signal 1 : une complication non annoncée

Ce qu'il peut signifier. Une complication survient, et vous découvrez qu'on ne vous en avait jamais parlé avant l'acte. Ce décalage interroge la qualité de l'information reçue. L'article L1111-2 du code de la santé publique impose au professionnel de vous informer des risques fréquents ou graves normalement prévisibles. En cas de litige, c'est à lui de prouver qu'il vous a bien informé.

Ce qu'il ne prouve pas. Une complication non annoncée ne signifie pas qu'elle était évitable, ni qu'un geste a été mal exécuté. Certains risques sont rares ou imprévisibles. Le défaut d'information est une question distincte de la faute technique, et il ne se déduit pas de la seule survenue du problème.

Ce qu'il faut faire. Notez par écrit, dès que possible, ce qu'on vous a dit avant l'acte, et ce qu'on ne vous a pas dit. Conservez tout document de consentement signé. Demandez votre dossier médical. Seuls un avocat et un médecin-conseil pourront dire si un manquement au devoir d'information existe.

Signal 2 : une discordance entre le discours et le dossier

Ce qu'il peut signifier. Le praticien vous explique une chose oralement, mais le compte rendu écrit en dit une autre, ou reste muet sur l'essentiel. Cette discordance mérite attention, car le dossier médical est la mémoire officielle de vos soins. Ce qui y figure, et ce qui n'y figure pas, pèse lourd dans toute analyse ultérieure.

Ce qu'il ne prouve pas. Une imprécision de rédaction n'est pas une dissimulation. Un compte rendu peut être incomplet sans qu'aucune faute de soin n'ait été commise. À l'inverse, un dossier parfaitement tenu n'exclut jamais, à lui seul, l'existence d'un manquement.

Ce qu'il faut faire. Mettez côte à côte ce qu'on vous a dit et ce que le dossier indique. Consignez les écarts par écrit, avec les dates. Ne modifiez rien, ne demandez aucune réécriture. Gardez les documents tels quels. C'est leur confrontation, par un professionnel, qui aura de la valeur.

Signal 3 : une réintervention rapide non prévue

Ce qu'il peut signifier. Vous êtes réopéré peu après un premier acte, alors que rien ne le laissait prévoir. Une reprise chirurgicale rapide peut interroger le déroulement de la première intervention. Elle peut aussi être la réponse adaptée à une complication survenue malgré des soins conformes.

Ce qu'il ne prouve pas. Une réintervention n'est pas l'aveu d'une erreur. Elle fait parfois partie d'un parcours médical normal, ou constitue la bonne décision face à un imprévu. La rapidité seule ne dit rien de la faute. Elle dit seulement qu'un événement a imposé un nouveau geste.

Ce qu'il faut faire. Demandez les comptes rendus des deux interventions ainsi que le motif écrit de la reprise. Notez les dates précises et l'enchaînement des événements. Conservez vos échanges avec l'équipe. L'analyse du lien entre les deux actes relève d'un médecin-conseil, jamais de votre seule impression.

Signal 4 : aucune information sur un risque grave qui s'est réalisé

Ce qu'il peut signifier. Un risque grave se produit, et vous êtes certain qu'on ne vous en avait jamais averti. Le droit français protège spécifiquement cette situation. La Cour de cassation a consacré un préjudice autonome, dit préjudice d'impréparation : le fait de ne pas avoir pu se préparer aux conséquences d'un risque grave qui se réalise ouvre droit à réparation.

« le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation »

Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.123 :
<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413>

Ce qu'il ne prouve pas. Ce préjudice d'impréparation ne se confond pas avec une faute technique de soin. Il concerne l'information, pas le geste. Sa reconnaissance suppose que le défaut d'information soit établi et invoqué, ce qui relève d'une analyse juridique, non d'une évidence.

Ce qu'il faut faire. Écrivez ce que vous avez compris avant l'acte, et ce qui ne vous a pas été dit. Rassemblez les documents de consentement. Un avocat, avec un médecin-conseil, mesurera si ce préjudice d'impréparation peut être soulevé dans votre cas.

Signal 5 : une infection survenue après une hospitalisation

Ce qu'il peut signifier. Une infection apparaît après un séjour à l'hôpital ou en clinique. On parle d'infection nosocomiale lorsqu'elle est contractée dans l'établissement. La loi la traite à part. L'article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements en sont responsables de plein droit, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Ce qu'il ne prouve pas. Toutes les infections ne sont pas nosocomiales, et toutes les infections nosocomiales n'ouvrent pas les mêmes droits. Le régime dépend notamment de la gravité des séquelles. La qualification d'infection nosocomiale, son origine et ses conséquences juridiques ne se déduisent pas de votre ressenti.

Ce qu'il faut faire. Conservez tous les documents mentionnant l'infection : comptes rendus, résultats d'analyses, prescriptions d'antibiotiques, dates d'apparition des symptômes. Ne jetez aucun justificatif de soins liés. Ces éléments permettront à un professionnel d'apprécier le régime applicable et vos droits éventuels.

Signal 6 : une aggravation inexpliquée de votre état

Ce qu'il peut signifier. Votre état se dégrade sans explication claire, alors que l'évolution attendue était favorable. Une aggravation inexpliquée peut interroger la surveillance, la prise en charge ou un diagnostic manqué en cours de route. Elle mérite qu'on remonte la chronologie des soins.

Ce qu'il ne prouve pas. Une évolution défavorable n'est pas, en soi, la marque d'une faute. Le corps humain réagit parfois de façon imprévue. Une aggravation peut relever de l'aléa thérapeutique, cette part d'incertitude inhérente à tout acte médical, sans qu'aucun manquement n'ait été commis.

Ce qu'il faut faire. Tenez un relevé daté de l'évolution de vos symptômes et de vos rendez-vous. Notez ce qui vous a été dit à chaque étape. Rassemblez vos examens successifs. La comparaison entre l'évolution attendue et l'évolution réelle est un travail de médecin-conseil.

Signal 7 : un refus de communiquer votre dossier médical

Ce qu'il peut signifier. Vous demandez votre dossier et on tarde, on filtre, ou on refuse. L'accès à votre dossier est pourtant un droit. L'article L1111-7 du code de la santé publique organise sa communication au plus tard dans les 8 jours suivant la demande, délai porté à 2 mois si les informations datent de plus de 5 ans.

Ce qu'il ne prouve pas. Une lenteur administrative n'est pas la preuve d'une dissimulation, ni d'une faute de soin. Des retards existent pour des raisons banales. Un refus, même injustifié, ne dit rien à lui seul de la qualité des soins reçus. Il concerne l'accès au document, pas son contenu.

Ce qu'il faut faire. Renouvelez votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'établissement est public, le refus peut être porté devant la Commission d'accès aux documents administratifs, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Pour un praticien libéral, la voie est la saisine du conseil départemental de l'Ordre des médecins, garant du code de déontologie (article R4127-46 du code de la santé publique). Un avocat peut vous aider à formaliser ces démarches.

Signal 8 : l'absence de consentement éclairé documenté

Ce qu'il peut signifier. Aucun document ne trace le consentement que vous auriez donné en connaissance des risques. Or l'information préalable et le consentement sont au cœur du droit des patients. L'article L1111-2 rappelle que la preuve de l'information délivrée incombe au professionnel. Une absence de trace le fragilise donc, lui, sur ce point.

Ce qu'il ne prouve pas. L'absence de document écrit ne suffit pas à établir un défaut d'information. La preuve peut être rapportée par tout moyen. Et un défaut d'information, même établi, reste distinct d'une faute dans l'exécution du geste médical lui-même. Ce sont deux questions séparées.

Ce qu'il faut faire. Recherchez et conservez tout formulaire signé, courrier ou compte rendu de consultation préopératoire. Notez ce dont vous vous souvenez des explications reçues. Ne reconstituez rien de faux. Un avocat et un médecin-conseil apprécieront si le devoir d'information a été respecté.

Signal 9 : un retard de diagnostic

Ce qu'il peut signifier. Un diagnostic est posé tardivement, et ce retard a pu peser sur vos chances de guérison ou sur la lourdeur des soins. Le retard de diagnostic est l'une des situations les plus fréquemment évoquées. Il peut interroger l'interprétation d'un examen ou l'orientation vers le bon spécialiste.

Ce qu'il ne prouve pas. Un diagnostic difficile n'est pas un diagnostic fautif. Certaines maladies sont trompeuses, silencieuses ou atypiques. Un retard n'implique pas automatiquement une perte de chance indemnisable. L'existence et l'ampleur d'une éventuelle perte de chance, cette probabilité perdue d'une évolution plus favorable, s'évaluent au cas par cas.

Ce qu'il faut faire. Reconstituez la chronologie précise : premiers symptômes, consultations, examens, date du diagnostic. Rassemblez les comptes rendus d'imagerie et d'analyses. Conservez les dates. C'est en confrontant cette chronologie aux règles de l'art qu'un médecin-conseil pourra se prononcer, jamais votre seule impression de lenteur.

Signal 10 : une erreur de site ou de dosage

Ce qu'il peut signifier. Vous apprenez qu'un mauvais côté a été opéré, un mauvais organe visé, ou qu'un médicament a été administré à une dose manifestement inadaptée. Ces situations, dites parfois « événements évitables », figurent parmi les plus sérieuses à documenter, car elles renvoient à la conformité même de l'acte.

Ce qu'il ne prouve pas. Même ici, la prudence reste de mise. Ce que vous croyez être une erreur de site ou de dosage peut recouvrir une réalité médicale plus complexe, un choix justifié ou une information incomplète de votre part. Rien ne se qualifie sur la seule foi d'une phrase entendue.

Ce qu'il faut faire. Notez immédiatement, par écrit et daté, ce qui a été dit, par qui, et dans quelles circonstances. Conservez ordonnances, étiquettes, comptes rendus et prescriptions. Demandez votre dossier sans attendre. Ces situations justifient particulièrement une analyse rapide par un avocat épaulé d'un médecin-conseil.

Le fil rouge : documenter, sans jamais qualifier soi-même

Vous l'avez lu dix fois, et c'est voulu : un signal invite à examiner, il ne conclut jamais. Personne ne peut qualifier une faute médicale à partir d'un ressenti, d'un mot mal perçu ou d'une évolution décevante. La qualification suppose de confronter votre dossier complet aux règles de l'art, ce que seuls un avocat en dommage corporel et un médecin-conseil savent faire ensemble.

Deux réflexes vous protègent dans tous les cas. Le premier est de documenter : écrire les faits, dater, conserver chaque pièce, demander votre dossier. Le second est de faire examiner, sans vous précipiter dans une accusation ni renoncer par découragement. Entre ces deux extrêmes se trouve la bonne attitude, celle qui préserve à la fois vos droits et votre tranquillité.

En un coup d'œil

CE QUI EST UTILE	CE QUI VOUS DESSERT
Écrire les faits et les dater	Attendre « d'y voir clair » pour tout noter
Demander et conserver le dossier	Accepter un refus sans le formaliser
Garder les documents tels quels	Réécrire ou faire corriger une pièce
Faire analyser par un professionnel	Qualifier soi-même une faute

Lexique express de ce document

- **Faute médicale** : manquement aux règles de l'art qui engage la responsabilité du professionnel. Elle se distingue de l'aléa et se qualifie après analyse du dossier.
- **Aléa thérapeutique** : part d'incertitude inhérente à tout acte médical, qui peut causer un dommage sans faute de personne.
- **Infection nosocomiale** : infection contractée dans un établissement de santé, soumise à un régime juridique particulier.
- **Devoir d'information** : obligation du professionnel de vous informer des risques fréquents ou graves. La preuve de l'information lui incombe.
- **Préjudice d'impréparation** : préjudice autonome subi lorsqu'un risque grave se réalise sans que vous ayez pu vous y préparer, faute d'information.
- **Perte de chance** : probabilité perdue d'une évolution plus favorable, évaluée au cas par cas.
- **Médecin-conseil** : médecin qui analyse votre dossier et défend vos intérêts aux côtés de votre avocat.
- **Consolidation** : moment où votre état de santé est stabilisé et où les lésions n'évoluent plus.

Votre prochaine étape

Aujourd'hui, ouvrez une pochette (physique ou numérique) et notez-y, daté, chaque signal que vous avez reconnu dans votre parcours. Ajoutez-y les documents que vous possédez déjà. Cette pochette sera la base d'une analyse future, sans rien engager pour l'instant.

Un mot du cabinet

Chez LEXVOX AVOCATS, nous accompagnons des victimes d'accidents médicaux dans la compréhension de leur dossier et la défense de leurs droits. Notre rôle n'est pas de vous promettre un résultat, mais de mettre à votre service la rigueur d'un cabinet dédié au dommage corporel, avec le concours de médecins-conseils. Si un ou plusieurs de ces signaux résonnent avec votre situation, la première consultation de 30 minutes est gratuite. Vous pouvez nous

joindre au 04 90 54 58 10 ou sur <https://lexvox-victime.com>. Nous recevons dans nos quatre bureaux en PACA : Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marnay.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

DOCUMENT 06

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

Le lexique et les textes de référence (erreur médicale)

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre en une phrase chaque mot technique que le médecin, l'établissement, l'expert ou l'avocat va employer dans votre dossier d'erreur médicale. - Reconnaître les 25 termes clés d'une indemnisation médicale, du consentement éclairé jusqu'à la saisine de la commission d'indemnisation. - Savoir précisément sur quels textes de loi repose la réparation d'un dommage lié aux soins, avec leur source officielle.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Après un dommage lié à des soins, vous entrez dans un univers de mots que personne ne vous a appris.

L'établissement écrit «aléa», le médecin parle de «consolidation», l'expert évoque le «DFP» et la «perte de chance». Chaque terme a un sens précis, et ce sens a un effet direct sur ce que vous pourrez obtenir. Ce document vous rend ce vocabulaire lisible. Gardez-le à portée de main pendant toute la durée de votre dossier.

Deux idées simples guident tout ce qui suit. D'abord, un mot mal compris peut vous coûter cher, car confondre une faute et un aléa, ou ignorer un délai de prescription, a des conséquences durables sur vos droits. Ensuite, chaque droit dont vous disposez a un fondement écrit, que vous pouvez vérifier vous-même. La première partie éclaire les mots, la seconde renvoie aux textes qui les soutiennent.

Partie 1. Les 25 définitions utiles

Les définitions ci-dessous sont classées par ordre alphabétique, pour que vous retrouviez chaque mot en quelques secondes. Elles suivent le fil d'un dossier réel, de l'information reçue avant l'acte jusqu'à la réparation du dommage. Un même terme peut apparaître dans un courrier de l'établissement, dans le rapport de l'expert et dans une décision de justice, avec exactement le même sens.

Accident médical. Dommage lié à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins qui n'est pas la simple conséquence prévisible de votre état de santé, et qui peut résulter soit d'une faute, soit d'un aléa.

AIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique). Pourcentage mesurant la réduction définitive de vos capacités après consolidation, qui sert notamment à apprécier la gravité de votre dommage et l'accès à la solidarité

nationale.

Aléa thérapeutique. Accident médical non fautif, c'est-à-dire un dommage survenu sans erreur du soignant, dont la réparation peut relever de la solidarité nationale lorsqu'il atteint un certain seuil de gravité.

Ayants droit. Proches d'un patient décédé, héritiers, concubin ou partenaire de PACS, qui peuvent accéder à son dossier médical pour connaître les causes de la mort, défendre sa mémoire ou faire valoir leurs droits.

CADA (Commission d'accès aux documents administratifs). Autorité que vous pouvez saisir lorsqu'un établissement de santé public refuse de vous communiquer votre dossier médical.

CCI (commission de conciliation et d'indemnisation). Instance amiable et gratuite que toute personne s'estimant victime d'un dommage médical peut saisir, et dont la saisine suspend les délais de prescription et de recours.

Consentement éclairé. Accord que vous donnez à un acte médical après avoir reçu une information complète sur son utilité, ses risques et les autres solutions possibles.

Consolidation. Moment médical où votre état est stabilisé et n'évolue plus, à partir duquel les séquelles peuvent être mesurées définitivement et à compter duquel court le délai de prescription.

Déficit fonctionnel permanent (DFP). Réduction définitive de vos capacités physiques ou mentales après consolidation, exprimée en pourcentage, qui traduit le retentissement durable des séquelles sur votre vie quotidienne.

Déficit fonctionnel temporaire (DFT). Gêne subie dans vos activités quotidiennes entre le dommage et la consolidation, pendant la période où vous n'avez pas encore retrouvé votre autonomie.

Devoir d'information. Obligation pour le professionnel de santé de vous informer des risques fréquents ou graves d'un acte, dont il doit prouver lui-même, en cas de litige, qu'il l'a bien remplie.

Dossier médical. Ensemble des informations de santé vous concernant, dont vous pouvez obtenir communication au plus tard dans les 8 jours suivant votre demande, délai porté à 2 mois si elles datent de plus de 5 ans.

Expertise contradictoire. Examen médical au cours duquel chaque partie peut être présente et discuter l'évaluation, afin qu'aucune conclusion ne vous soit imposée sans débat.

Faute médicale. Manquement du professionnel ou de l'établissement de santé à ses obligations de soins, de diagnostic ou d'information, qui engage sa responsabilité lorsque vous en subissez un dommage.

Infection nosocomiale. Infection contractée à l'occasion d'une prise en charge dans un établissement de santé, dont l'établissement répond de plein droit sauf s'il prouve une cause étrangère.

Médecin-conseil. Médecin qui intervient lors de l'expertise, soit pour le compte de l'assureur ou de l'établissement, soit à vos côtés, pour discuter l'évaluation médicale de vos préjudices.

Nomenclature Dintilhac. Liste de référence des postes de préjudice corporel, utilisée par les juges et les experts pour n'oublier aucun poste indemnisable, sans valeur de loi mais universellement appliquée.

ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux). Organisme public qui indemnise, au titre de la solidarité nationale, certains accidents médicaux non fautifs et infections nosocomiales graves.

Perte de chance. Disparition de la probabilité d'un événement favorable, par exemple la chance de guérison qu'une prise en charge correcte vous aurait offerte, indemnisée en proportion de la chance perdue.

Préjudice d'impréparation. Préjudice autonome subi lorsque, faute d'information, vous n'avez pas pu vous préparer aux conséquences d'un risque qui s'est réalisé, et que le juge ne peut laisser sans réparation.

Prescription. Délai au-delà duquel vous ne pouvez plus agir, fixé à 10 ans à compter de la consolidation du dommage pour les actions en responsabilité médicale et les demandes devant l'ONIAM.

Responsabilité de plein droit. Responsabilité engagée sans que vous ayez à prouver une faute, comme celle des établissements de santé pour les infections nosocomiales, sauf preuve d'une cause étrangère.

Solidarité nationale. Mécanisme par lequel l'ONIAM indemnise certains dommages médicaux non fautifs présentant un caractère de gravité, sans qu'aucune faute n'ait à être démontrée.

Tierce personne. Aide humaine, professionnelle ou familiale, dont vous avez besoin pour les actes de la vie courante lorsque vos séquelles vous privent d'autonomie.

Tribunal administratif / tribunal judiciaire. Juridictions compétentes selon la nature de l'établissement en cause, le tribunal administratif pour les hôpitaux publics et le tribunal judiciaire pour les praticiens et les cliniques privées.

Partie 2. Les textes de référence

Votre droit à réparation ne repose pas sur une faveur de l'établissement, mais sur des textes précis. Les connaître vous permet de vérifier que vos délais sont respectés et que vos droits ne sont pas oubliés. Voici les textes utiles à un dossier médical, chacun avec sa source officielle sur Légifrance. Les liens ci-dessous vous mènent directement à la version en vigueur.

Les textes de référence

Code de la santé publique, l'information et le dossier - Article L1111-2 du code de la santé publique. Droit du patient à l'information sur son état de santé et sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ; en cas de litige, la preuve que l'information a été délivrée incombe au professionnel ou à l'établissement.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137408 - Article L1111-7 du code de la santé publique. Accès de toute personne aux informations de santé la concernant, communiquées au plus tard dans les 8 jours suivant la demande, délai porté à 2 mois si les informations datent de plus de 5 ans.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685313 - Article L1110-4 du code de la santé publique. Accès des ayants droit au dossier après le décès, pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire du défunt.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043895798

Code de la santé publique, la responsabilité et l'indemnisation - Article L1142-1 du code de la santé publique. Responsabilité pour faute des professionnels de santé, responsabilité de plein droit des établissements pour les infections nosocomiales sauf cause étrangère, et réparation au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux graves non fautifs. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252 - Article L1142-1-1 du code de la santé publique. Réparation par la solidarité nationale des infections nosocomiales entraînant une atteinte permanente supérieure à 25 % ou le décès. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628248 - Article L1142-7 du code de la santé publique. Saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation par toute personne s'estimant victime d'un dommage médical, saisine qui suspend les délais de prescription et de recours contentieux. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721134 - Article L1142-28 du code de la santé publique. Prescription des actions en responsabilité médicale et des demandes devant l'ONIAM par 10 ans à compter de la consolidation du dommage. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033810165 - Article D1142-1 du code de la santé publique. Seuil de gravité ouvrant l'accès à la commission d'indemnisation et à la solidarité nationale : taux d'atteinte permanente fixé à 24 %, ou déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant 6 mois. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023458773

Les voies de recours pour obtenir votre dossier - Article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Obligation pour les administrations de communiquer les documents qu'elles détiennent, fondement du recours devant la CADA face à un hôpital public.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033218946 - Article R4127-46 du code de la santé publique (code de déontologie médicale). Accès au dossier par l'intermédiaire d'un médecin, rattaché aux devoirs déontologiques du praticien, dont le respect relève du conseil de l'Ordre des médecins pour un praticien libéral.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025843577

La jurisprudence sur le préjudice d'impréparation - Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.123. Arrêt de principe : le non-respect du devoir d'information cause, lorsque le risque se réalise, un préjudice d'impréparation autonome que le juge ne peut laisser sans réparation.

<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413> - Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898. Confirmation : le préjudice moral d'impréparation, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033943617>

Deux précisions utiles. D'abord, le seuil qui ouvre l'accès à la commission d'indemnisation est un taux d'atteinte permanente de 24 %, valeur réglementaire fixée par l'article D1142-1, et non 25 %. Ensuite, la nomenclature Dintilhac, souvent citée pendant l'expertise, est un rapport de référence de juillet 2005 et non un texte de loi, sans

URL Légifrance ni valeur normative propre, mais les juges et les experts la suivent pour recenser tous vos postes de préjudice.

Votre prochaine étape Repérez dans vos documents médicaux les mots «consolidation», «aléa» et «information», puis vérifiez leur définition dans ce lexique avant d'accepter la moindre conclusion d'expertise.

Un accompagnement si vous le souhaitez

Ces mots deviennent des enjeux concrets dès la première expertise médicale. La SELARL LEXVOX AVOCATS, dont Me Patrice Humbert est spécialiste du dommage corporel, accompagne les victimes d'erreur médicale dans toute la région PACA, depuis ses bureaux d'Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane. La première consultation de 30 minutes est gratuite. Si un terme de votre dossier vous inquiète, si une conclusion d'expertise vous semble injuste ou si un délai approche, vous pouvez nous en parler avant de prendre la moindre décision. Vous joignez le standard au 04 90 54 58 10, et vous retrouvez l'ensemble de nos ressources sur <https://lexvox-victime.com>.

Maître Patrice Humbert

AVOCAT AU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE · TOQUE 187 · SPÉCIALISTE CNB EN DOMMAGE CORPOREL
MASTER EN DROIT DE LA SANTÉ · FORMATION MÉDICALE EN TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL
SELARL LEXVOX AVOCATS · 4 BUREAUX EN PACA · 04 90 54 58 10 · LEXVOX-VICTIME.COM

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15.